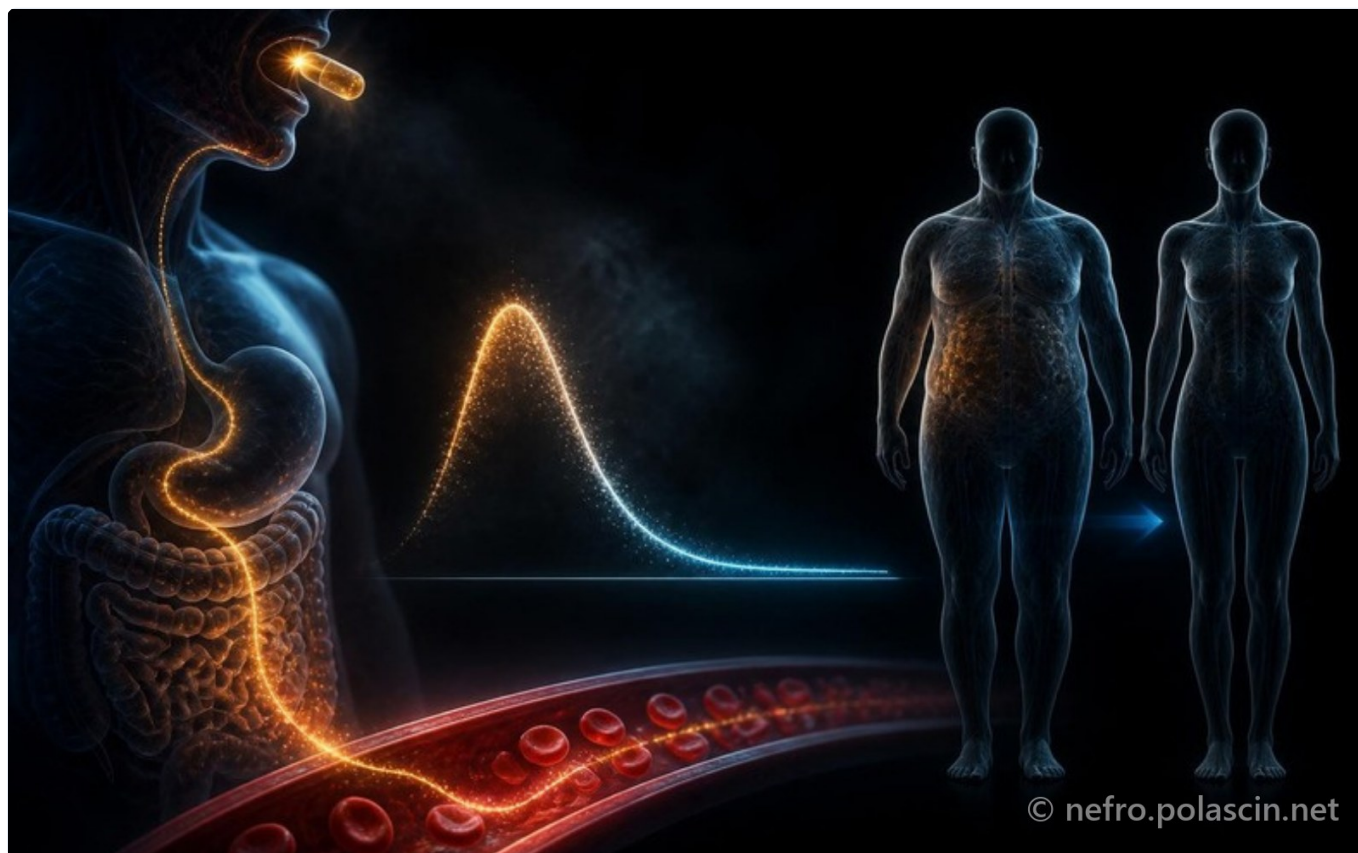


Nový perorálny agonista GLP-1 elekoglipron: výsledky fázy 2 so zlepšením HbA1c a redukciou hmotnosti

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 13.06.2026



Poloschematická vizualizácia. Tabletkami namiesto injekcie mení dostupnosť liečby — fáza 2 je však stále len medzikrok.

Elekoglipron je nový perorálny agonista receptora pre GLP-1 (malá molekula). V dvoch štúdiách fázy 2 dosiahol **klinicky významné zníženie HbA1c a glukózy** u ľudí s diabetom 2. typu a zároveň **významnú redukciu hmotnosti** u populácie s obezitou alebo nadváhou (bez diabetu 2. typu).

Prečo je to zaujímavé aj z nefrologického pohľadu

Chronická hyperglykémia a obezita sú spojené s vyšším rizikom kardiometabolických komplikácií a aj poškodenia obličiek. Kombinácia účinku na metabolizmus a hmotnosť by teoreticky mohla viesť k zlepšeniu kardiometabolických profilov, ktoré zahŕňajú aj rizikové faktory pre kardiovaskulárne a renálne udalosti.

Dôležité upozornenie. Ide primárne o **výsledky fázy 2**. Dlhodobé renálne outcome (tvrdé obličkové ciele) v tejto fáze **ešte nie sú preukázané** a budú predmetom ďalších štúdií.

SOLSTICE (fáza 2b): diabetes 2. typu, HbA1c a hmotnosť

Do štúdie bolo zaradených **406** pacientov s diabetom 2. typu. Randomizácia zahŕňala:

- perorálne dávky elekoglipronu **5 mg, 15 mg alebo 25 mg** raz denne,
- rôzne schémy titrácie (vrátane cieľových dávok a eskalácie),
- placebo,
- a exploratórnu skupinu s perorálnym semaglutidom titrovaným na 14 mg.

Výsledky za 26 týždňov

- **HbA1c klesalo dávkovo závisle** a vo všetkých dávkach bolo zníženie väčšie než placebo. Uvádzaný rozsah: zníženie približne **0,91 %** pri 5 mg až **1,88 %** pri najvyššej dávke v schéme eskalácie.
- **Hmotnosť klesala** tiež v závislosti od dávky: približne **2,54 %** (5 mg) až **7,61 %** pri najvyššej dávke pri eskalácii každé 2 týždne.
- Pri schéme s najvyššou dávkou dosiahol **väčší podiel pacientov aspoň 5 % redukciu hmotnosti** oproti placebo.
- Zaznamenané boli aj zlepšenia niektorých **markerov krvného tlaku a pečenných biomarkerov**.

Bezpečnosť a tolerancia

- Nežiaduce udalosti boli v súlade s triedou GLP-1 (gastrointestinálne príznaky).
- Najčastejšie boli **nausea, zápcha, hnačka, vrátane vracania**.
- Časť pacientov musela liečbu ukončiť pre nežiaduce účinky, najmä pri vyšších dávkach a určitých titračných schémach.

VISTA (fáza 2): obezita alebo nadváha s komorbiditou, bez diabetu 2. typu

Do VISTA bolo zaradených **310** účastníkov s obezitou alebo nadváhou s aspoň jednou hmotnostne súvisiacou komorbiditou a **bez diabetu 2. typu**.

Dávkovanie

- týždenné titrovanie elekglipronu v rôznych dávkach,
- vrátane režimu s titráciou každé 2 týždne (pri 75 mg),
- placebo.

Výsledky za 26 týždňov

- Priemerná redukcia telesnej hmotnosti sa pohybovala približne od **2,6 %** (najnižšia dávka) po **10,5 %** (najvyššia týždenná titrácia) oproti **0,6 %** v skupine placebo.
- Ko-primárny cieľ (podiel pacientov s aspoň 5 % redukciou hmotnosti) bol **88,8 %** v elekglipronovej skupine vs. **15,6 %** na placebe.
- Pri predĺžení na **36 týždňov** sa pri niektorých ukazovateľoch redukcia hmotnosti ďalej zvyšovala a nedošlo k jasnému „plateau“ už po 26 týždňoch.

Bezpečnosť

Nežiaduce udalosti boli podobného typu ako v SOLSTICE: opäť najmä gastrointestinálne príznaky.

Porovnanie s injekčnými inkretínovými terapiami

Výsledná miera redukcie hmotnosti s elekglipronom je **porovnateľná s inými perorálnymi malomolekulovými agonistami GLP-1**, ale **nižšia než miery hlásené pri niektorých injekčných inkretínových terapiách** s vyššou účinnosťou v redukcii hmotnosti.

Súčasne sa zdôrazňuje praktický benefit: **perorálne podanie** bez potreby prísnych režimových obmedzení, ktoré môžu byť problematické pri niektorých iných perorálnych GLP-1 liekoch.

Čo z toho vyplýva do praxe a čo ešte chýba

Tieto výsledky **odôvodňujú pokračovanie** do fázy 3 (dlhšie sledovanie, širší výber populácie, relevantné kardiometabolické outcome a optimalizácia dávok a titračných schém).

Pre nefrologickú prax je kľúčové rozlišovať:

- **čo už vieme:** zlepšenia HbA1c a telesnej hmotnosti v štúdiách fázy 2,
- **čo ešte nevieme:** či sa tieto zmeny premietnu do konkrétnych dlhodobých **renálnych outcome** (predmet ďalších štúdií).

Zdroj: Medscape, „Novel Oral GLP-1 Shows A1c and Weight Loss Benefits“ (ADA 2026; SOLSTICE a VISTA).

Upozornenie: Článok má informačný a vzdelávací charakter, sumarizuje publikované výsledky fázy 2 a nenahrádza odborné posúdenie ani aktuálne schválené indikácie a SPC.

Zdroj: <https://nefro.polasci.net/article.php?slug=elekoglipron-peroralny-glp1-agonista-faza-2> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.